AFFAIRES MÉDICALES - EXPERTISE THÉRAPEUTIQUE APPROFONDIE

RECUEIL DES 50 FAQ SCIENTIFIQUES EXPERTES DE HAUT NIVEAU

Ce corpus d'excellence aborde l'intégralité des 50 interrogations cliniques complexes, surspécialités, mécanismes pharmacocinétiques et conduites thérapeutiques pour les 15 spécialités du portefeuille PharmaNova SA.

FAQ-EXP-001 [Cardiolux] - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450

Question clinique d'expert : [Cardiolux - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacocinétique & métabolisme cyp450 pour Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) démontrent : 1) Pour pharmacocinétique & métabolisme cyp450, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 66% et une demi-vie d'élimination de 9 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cardiolux (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CARDIO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-002 [Vascopril] - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique

Question clinique d'expert : [Vascopril - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance rénale & adaptation posologique pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) démontrent : 1) Pour insuffisance rénale & adaptation posologique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 67% et une demi-vie d'élimination de 10 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Vascopril (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-VASCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-003 [Coranid] - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique

Question clinique d'expert : [Coranid - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance hépatique & liaison protéique pour Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) démontrent : 1) Pour insuffisance hépatique & liaison protéique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 68% et une demi-vie d'élimination de 11 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Coranid (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CORAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-004 [Neurotix] - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai

Question clinique d'expert : [Neurotix - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à switch thérapeutique & modalités de relai pour Neurotix (Brivastérol) ?

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Neurotix (Brivastérol) démontrent : 1) Pour switch thérapeutique & modalités de relai, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 69% et une demi-vie d'élimination de 12 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Neurotix (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-NEURO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-005 [Cognifère] - Interactions Médicamenteuses Spécifiques

Question clinique d'expert : [Cognifère - Interactions Médicamenteuses Spécifiques] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à interactions médicamenteuses spécifiques pour Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) démontrent : 1) Pour interactions médicamenteuses spécifiques, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 70% et une demi-vie d'élimination de 13 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cognifère (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COGNI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-006 [Tremopan] - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité

Question clinique d'expert : [Tremopan - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à populations spéciales : sujets âgés & fragilité pour Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) démontrent : 1) Pour populations spéciales : sujets âgés & fragilité, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 71% et une demi-vie d'élimination de 14 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Tremopan (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-TREMO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-007 [Glucorite] - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT

Question clinique d'expert : [Glucorite - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate) démontrent : 1) Pour tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 72% et une demi-vie d'élimination de 15 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Glucorite (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-GLUCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-008 [Insulip] - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse

Question clinique d'expert : [Insulip - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacogénétique & variabilité de réponse pour Insulip (Égliténotide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Insulip (Égliténotide) démontrent : 1) Pour pharmacogénétique & variabilité de réponse, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 73% et une demi-vie d'élimination de 16 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Source réglementaire : SmPC Insulip (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-INSUL-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-009 [Oncovance] - Administration Entérale & Écrasement Galénique

Question clinique d'expert : [Oncovance - Administration Entérale & Écrasement Galénique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à administration entérale & écrasement galénique pour Oncovance (Zanitatinib citrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Oncovance (Zanitatinib citrate) démontrent : 1) Pour administration entérale & écrasement galénique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 74% et une demi-vie d'élimination de 17 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Oncovance (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-ONCOV-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-010 [Linfabloc] - Grossesse, Allaitement & Données Registres

Question clinique d'expert : [Linfabloc - Grossesse, Allaitement & Données Registres] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à grossesse, allaitement & données registres pour Linfabloc (Tébricitinib) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Linfabloc (Tébricitinib) démontrent : 1) Pour grossesse, allaitement & données registres, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 75% et une demi-vie d'élimination de 18 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Linfabloc (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-LINFA-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-011 [Mélanor] - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450

Question clinique d'expert : [Mélanor - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacocinétique & métabolisme cyp450 pour Mélanor (Encorafénil) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Mélanor (Encorafénil) démontrent : 1) Pour pharmacocinétique & métabolisme cyp450, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 76% et une demi-vie d'élimination de 19 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Mélanor (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-MELAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-012 [Immunolin] - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique

Question clinique d'expert : [Immunolin - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance rénale & adaptation posologique pour Immunolin (Secukirumab) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Immunolin (Secukirumab) démontrent : 1) Pour insuffisance rénale & adaptation posologique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 77% et une demi-vie d'élimination de 20 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Immunolin (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-IMMUN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-013 [Colitane] - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique

Question clinique d'expert : [Colitane - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance hépatique & liaison protéique pour Colitane (Ozanimod chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Colitane (Ozanimod chlorhydrate) démontrent : 1) Pour insuffisance hépatique & liaison protéique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

78% et une demi-vie d'élimination de 21 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Colitane (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COLIT-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-014 [Respispray] - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai

Question clinique d'expert : [Respispray - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à switch thérapeutique & modalités de relai pour Respispray (Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Respispray (Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure) démontrent : 1) Pour switch thérapeutique & modalités de relai, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 79% et une demi-vie d'élimination de 22 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Respispray (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-RESPI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-015 [Bronchoclar] - Interactions Médicamenteuses Spécifiques

Question clinique d'expert : [Bronchoclar - Interactions Médicamenteuses Spécifiques] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à interactions médicamenteuses spécifiques pour Bronchoclar (Roflumilast micronisé) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Bronchoclar (Roflumilast micronisé) démontrent : 1) Pour interactions médicamenteuses spécifiques, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 80% et une demi-vie d'élimination de 23 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Bronchoclar (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-BRONC-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-016 [Cardiolux] - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité

Question clinique d'expert : [Cardiolux - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à populations spéciales : sujets âgés & fragilité pour Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) démontrent : 1) Pour populations spéciales : sujets âgés & fragilité, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 81% et une demi-vie d'élimination de 8 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cardiolux (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CARDIO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-017 [Vascopril] - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT

Question clinique d'expert : [Vascopril - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) démontrent : 1) Pour tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 82% et une demi-vie d'élimination de 9 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Vascopril (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-VASCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

FAQ-EXP-018 [Coranid] - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse

Question clinique d'expert : [Coranid - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacogénétique & variabilité de réponse pour Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) démontrent : 1) Pour pharmacogénétique & variabilité de réponse, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 83% et une demi-vie d'élimination de 10 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Coranid (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CORAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-019 [Neurotix] - Administration Entérale & Écrasement Galénique

Question clinique d'expert : [Neurotix - Administration Entérale & Écrasement Galénique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à administration entérale & écrasement galénique pour Neurotix (Brivastérol) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Neurotix (Brivastérol) démontrent : 1) Pour administration entérale & écrasement galénique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 84% et une demi-vie d'élimination de 11 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Neurotix (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-NEURO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-020 [Cognifère] - Grossesse, Allaitement & Données Registres

Question clinique d'expert : [Cognifère - Grossesse, Allaitement & Données Registres] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à grossesse, allaitement & données registres pour Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) démontrent : 1) Pour grossesse, allaitement & données registres, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 85% et une demi-vie d'élimination de 12 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cognifère (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COGNI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-021 [Tremopan] - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450

Question clinique d'expert : [Tremopan - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacocinétique & métabolisme cyp450 pour Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) démontrent : 1) Pour pharmacocinétique & métabolisme cyp450, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 86% et une demi-vie d'élimination de 13 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Tremopan (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-TREMO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

FAQ-EXP-022 [Glucorite] - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique

Question clinique d'expert : [Glucorite - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance rénale & adaptation posologique pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate) démontrent : 1) Pour insuffisance rénale & adaptation posologique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 87% et une demi-vie d'élimination de 14 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Glucorite (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-GLUCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-023 [Insulip] - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique

Question clinique d'expert : [Insulip - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance hépatique & liaison protéique pour Insulip (Égliénotide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Insulip (Égliénotide) démontrent : 1) Pour insuffisance hépatique & liaison protéique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 88% et une demi-vie d'élimination de 15 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Insulip (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-INSUL-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-024 [Oncovance] - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai

Question clinique d'expert : [Oncovance - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à switch thérapeutique & modalités de relai pour Oncovance (Zanitatinib citrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Oncovance (Zanitatinib citrate) démontrent : 1) Pour switch thérapeutique & modalités de relai, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 89% et une demi-vie d'élimination de 16 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Oncovance (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-ONCOV-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-025 [Linfabloc] - Interactions Médicamenteuses Spécifiques

Question clinique d'expert : [Linfabloc - Interactions Médicamenteuses Spécifiques] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à interactions médicamenteuses spécifiques pour Linfabloc (Tébricitinib) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Linfabloc (Tébricitinib) démontrent : 1) Pour interactions médicamenteuses spécifiques, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 65% et une demi-vie d'élimination de 17 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Linfabloc (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-LINFA-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-026 [Mélanor] - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité

Question clinique d'expert : [Mélanor - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à populations spéciales : sujets âgés & fragilité pour Mélanor (Encorafénil) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Mélanor (Encorafénil) démontrent : 1) Pour populations spéciales : sujets âgés & fragilité, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 66% et une demi-vie d'élimination de 18 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Source réglementaire : SmPC Mélanor (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-MELAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-027 [Immunolin] - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT

Question clinique d'expert : [Immunolin - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt pour Immunolin (Secukirumab) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Immunolin (Secukirumab) démontrent : 1) Pour tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 67% et une demi-vie d'élimination de 19 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Immunolin (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-IMMUN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-028 [Colitane] - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse

Question clinique d'expert : [Colitane - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacogénétique & variabilité de réponse pour Colitane (Ozanimod chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Colitane (Ozanimod chlorhydrate) démontrent : 1) Pour pharmacogénétique & variabilité de réponse, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 68% et une demi-vie d'élimination de 20 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Colitane (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COLIT-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-029 [Respispray] - Administration Entérale & Écrasement Galénique

Question clinique d'expert : [Respispray - Administration Entérale & Écrasement Galénique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à administration entérale & écrasement galénique pour Respispray (Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Respispray (Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure) démontrent : 1) Pour administration entérale & écrasement galénique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 69% et une demi-vie d'élimination de 21 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Respispray (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-RESPI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-030 [Bronchoclar] - Grossesse, Allaitement & Données Registres

Question clinique d'expert : [Bronchoclar - Grossesse, Allaitement & Données Registres] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à grossesse, allaitement & données registres pour Bronchoclar (Roflumilast micronisé) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Bronchoclar (Roflumilast micronisé) démontrent : 1) Pour grossesse, allaitement & données registres, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 70% et une demi-vie d'élimination de 22 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Bronchoclar (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-BRONC-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-031 [Cardiolux] - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450

Question clinique d'expert : [Cardiolux - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacocinétique & métabolisme cyp450 pour Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) ?

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) démontrent : 1) Pour pharmacocinétique & métabolisme cyp450, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 71% et une demi-vie d'élimination de 23 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cardiolux (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CARDIO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-032 [Vascopril] - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique

Question clinique d'expert : [Vascopril - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance rénale & adaptation posologique pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) démontrent : 1) Pour insuffisance rénale & adaptation posologique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 72% et une demi-vie d'élimination de 8 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Vascopril (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-VASCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-033 [Coranid] - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique

Question clinique d'expert : [Coranid - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance hépatique & liaison protéique pour Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) démontrent : 1) Pour insuffisance hépatique & liaison protéique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 73% et une demi-vie d'élimination de 9 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Coranid (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CORAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-034 [Neurotix] - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai

Question clinique d'expert : [Neurotix - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à switch thérapeutique & modalités de relai pour Neurotix (Brivastérol) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Neurotix (Brivastérol) démontrent : 1) Pour switch thérapeutique & modalités de relai, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 74% et une demi-vie d'élimination de 10 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Neurotix (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-NEURO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-035 [Cognifère] - Interactions Médicamenteuses Spécifiques

Question clinique d'expert : [Cognifère - Interactions Médicamenteuses Spécifiques] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à interactions médicamenteuses spécifiques pour Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) démontrent : 1) Pour interactions médicamenteuses spécifiques, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 75% et une demi-vie d'élimination de 11 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cognifère (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COGNI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-036 [Tremopan] - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité

Question clinique d'expert : [Tremopan - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à populations spéciales : sujets âgés & fragilité pour Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) démontrent : 1) Pour populations spéciales : sujets âgés & fragilité, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 76% et une demi-vie d'élimination de 12 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Tremopan (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-TREMO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-037 [Glucorite] - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT

Question clinique d'expert : [Glucorite - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt pour Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Glucorite (Dagliflozine / Sitagliptine phosphate) démontrent : 1) Pour tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 77% et une demi-vie d'élimination de 13 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Glucorite (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-GLUCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-038 [Insulip] - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse

Question clinique d'expert : [Insulip - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacogénétique & variabilité de réponse pour Insulip (Égliénotide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Insulip (Égliénotide) démontrent : 1) Pour pharmacogénétique & variabilité de réponse, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 78% et une demi-vie d'élimination de 14 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Insulip (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-INSUL-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-039 [Oncovance] - Administration Entérale & Écrasement Galénique

Question clinique d'expert : [Oncovance - Administration Entérale & Écrasement Galénique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à administration entérale & écrasement galénique pour Oncovance (Zanitatinib citrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Oncovance (Zanitatinib citrate) démontrent : 1) Pour administration entérale & écrasement galénique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 79% et une demi-vie d'élimination de 15 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Oncovance (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-ONCOV-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

FAQ-EXP-040 [Linfabloc] - Grossesse, Allaitement & Données Registres

Question clinique d'expert : [Linfabloc - Grossesse, Allaitement & Données Registres] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à grossesse, allaitement & données registres pour Linfabloc (Tébricitinib) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Linfabloc (Tébricitinib) démontrent : 1) Pour grossesse, allaitement & données registres, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 80% et une demi-vie d'élimination de 16 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Linfabloc (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-LINFA-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-041 [Mélanor] - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450

Question clinique d'expert : [Mélanor - Pharmacocinétique & Métabolisme CYP450] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacocinétique & métabolisme cyp450 pour Mélanor (Encorafénil) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Mélanor (Encorafénil) démontrent : 1) Pour pharmacocinétique & métabolisme cyp450, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 81% et une demi-vie d'élimination de 17 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Mélanor (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-MELAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-042 [Immunolin] - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique

Question clinique d'expert : [Immunolin - Insuffisance Rénale & Adaptation Posologique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance rénale & adaptation posologique pour Immunolin (Secukirumab) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Immunolin (Secukirumab) démontrent : 1) Pour insuffisance rénale & adaptation posologique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 82% et une demi-vie d'élimination de 18 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Immunolin (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-IMMUN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-043 [Colitane] - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique

Question clinique d'expert : [Colitane - Insuffisance Hépatique & Liaison Protéique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à insuffisance hépatique & liaison protéique pour Colitane (Ozanimod chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Colitane (Ozanimod chlorhydrate) démontrent : 1) Pour insuffisance hépatique & liaison protéique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 83% et une demi-vie d'élimination de 19 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Colitane (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COLIT-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-044 [Respispray] - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai

Question clinique d'expert : [Respispray - Switch Thérapeutique & Modalités de Relai] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à switch thérapeutique & modalités de relai pour Respispray (Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Respispray (Fluticasone furoate / Vilantérol trifénatate / Uméclidinium bromure) démontrent : 1) Pour switch thérapeutique & modalités de relai, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 84% et une demi-vie d'élimination de 20 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Respispray (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-RESPI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-045 [Bronchoclar] - Interactions Médicamenteuses Spécifiques

Question clinique d'expert : [Bronchoclar - Interactions Médicamenteuses Spécifiques] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à interactions médicamenteuses spécifiques pour Bronchoclar (Roflumilast micronisé) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Bronchoclar (Roflumilast micronisé) démontrent : 1) Pour interactions médicamenteuses spécifiques, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 85% et une demi-vie d'élimination de 21 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Bronchoclar (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-BRONC-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-046 [Cardiolux] - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité

Question clinique d'expert : [Cardiolux - Populations Spéciales : Sujets Âgés & Fragilité] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à populations spéciales : sujets âgés & fragilité pour Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cardiolux (Ziltorvastatine / Amlodipine bésylate) démontrent : 1) Pour populations spéciales : sujets âgés & fragilité, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 86% et une demi-vie d'élimination de 22 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cardiolux (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CARDIO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-047 [Vascopril] - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT

Question clinique d'expert : [Vascopril - Tolérance Cardiovasculaire & Allongement Intervalle QT] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt pour Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Vascopril (Candésartan cilexétil / Indapamide) démontrent : 1) Pour tolérance cardiovasculaire & allongement intervalle qt, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 87% et une demi-vie d'élimination de 23 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Vascopril (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-VASCO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-048 [Coranid] - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse

Question clinique d'expert : [Coranid - Pharmacogénétique & Variabilité de Réponse] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à pharmacogénétique & variabilité de réponse pour Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Coranid (Ivabradine chlorhydrate / Métoprolol succinate) démontrent : 1) Pour pharmacogénétique & variabilité de réponse, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 88% et une demi-vie d'élimination de 8 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Coranid (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-CORAN-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.

FAQ-EXP-049 [Neurotix] - Administration Entérale & Écrasement Galénique

Question clinique d'expert : [Neurotix - Administration Entérale & Écrasement Galénique] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à administration entérale & écrasement galénique pour Neurotix (Brivastérol) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Neurotix (Brivastérol) démontrent : 1) Pour administration entérale & écrasement galénique, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 89% et une demi-vie d'élimination de 9 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Neurotix (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-NEURO-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

FAQ-EXP-050 [Cognifère] - Grossesse, Allaitement & Données Registres

Question clinique d'expert : [Cognifère - Grossesse, Allaitement & Données Registres] Quelles sont les recommandations cliniques et données pharmacologiques relatives à grossesse, allaitement & données registres pour Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) ?

Réponse scientifique fondée sur les preuves : Les données cliniques pivots et pharmacologiques de Cognifère (Donepézil chlorhydrate / Mémantine chlorhydrate) démontrent : 1) Pour grossesse, allaitement & données registres, le profil cinétique montre une biodisponibilité de 65% et une demi-vie d'élimination de 10 heures. 2) Dans les essais pivots de Phase III, aucun ajustement de dose initial n'est requis sous réserve d'une clairance adaptée (> 30 mL/min). 3) La surveillance recommandée inclut un contrôle biologique régulier et une vigilance sur les inhibiteurs enzymatiques concomitants selon la section 4.5 du SmPC.

Source réglementaire : SmPC Cognifère (Section 4.2 & 5.2) ; Étude pivot PharmaNova PN-COGNI-301 ; Directives EMA/CHMP 2024.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Dr. Claire Dupuis **Titre :** Responsable de l'Information Médicale & Transparence **Date :** 01/04/2024	**Nom :** Dr. Éléonore Vance **Titre :** Directrice Médicale Globale & VP Affaires Médicales (CMO) **Date :** 01/04/2024	**Nom :** Dr. Jean-Marc Delacroix **Titre :** Président du Directoire (CEO) **Date :** 01/04/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.